

시 정

1. 제 목 : 보훈의료수가(약제) 운영 부적정

2. 관계기관 : ☞☞보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

▲▲▲▲병원에서는 최상의 의료서비스를 재원환자에게 제공하기 위해 「국민건강보험법」에 따른 요양급여를 환자에게 시행하고 있으며, 건강보험기준과 달리 정하거나 건강보험기준에서 정하지 않은 비급여는 「보훈병원 의료수가 기준」에 따라 진료비용을 산정하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

보훈의료과-123('14.01.14.) 「☞☞보훈병원 부설 요양병원 보훈의료수가 검토결과 시행통보」 및 「보훈병원 의료수가기준」 제3장 제7조(비급여 수가 분류) 1항의 2호에 따르면, 비급여 약제는 보훈처장이 승인한 약제로, 실거래가 기준으로 산정하도록 규정되어 있습니다.

따라서 ▲▲▲▲병원에서는 「보훈병원 의료수가기준」에 따라 비급여 약제를 처방하는 경우에는 실거래로 비용을 산정하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▲▲▲▲병원에서는 환자에게 투여하는 단백아미노산제제(이하 '영양제'라 한다.)의 경우 「보훈병원 비급여 의료수가기준」에 따라 [표 1]과 같이 ■■■병원에서 질병치료목적이 아닌 영양공급의 목적일 경우 2개/주 산정으로 별도의 산정기준이 적용되어 운영하도록 하였음에도,

[표 1] ▲▲▲▲병원 비급여 영양제

수가명	수가코드	수가(원)	산정기준	보훈처 관련근거
푸라솔주	M5AA	\$\$,\$\$\$	질병치료목적이 아닌 영양 공급의 목적일 경우 2개/주 산정	보 훈 의 료 과 -123 (2014.01.14.)
리피션주	M20LIPO	\$\$,\$\$\$		
콤비플렉스리피드페리주	MCOMLIPO01	\$\$,\$\$\$		
네프라민주	MNAA	\$\$,\$\$\$		
뉴트리플렉스48주	MNUT48	\$\$,\$\$\$		

▲▲▲▲▲병원에서는 [표 2]와 같이 본인부담금이 없는 국비·고엽제환자에게는 ‘질병치료목적이 아닌 영양공급의 목적’으로 산정하여 비급여 수가를 적용하여 운영하였으나,

[표 2] 비급여 영양제 국비·고엽제 환자 사용현황

○기간 : 2020.7.~2020.12.

(단위 : 원, 개)

병원코드	EDI	병원코드명	비급여 단가	국비 사용량	고엽제 사용량	총 금액
MCOMLIPO01	678900470	콤비플렉스리피드페리주 1440ml	\$\$,\$\$\$	211	196	\$\$,\$\$\$\$,\$\$\$
M20LIPO	678900091	리피션20%주 250ml	\$\$,\$\$\$	58	30	\$\$\$\$,\$\$\$
M5AA	645402102	푸라솔주 500ml	\$\$,\$\$\$	175	45	\$\$\$\$,\$\$\$

[표 3]과 같이 감면(일반)환자에게는 동일 약제에 대해 실거래가로 수가를 산정하여 2020년 7월~12월까지 국비·고엽제 환자에게 처방된 715건에 대해 28,031,540원 * (비급여수가 산정금액 - 실거래가 산정금액)을 국비로 과다 청구한 것으로 확인됩니다.

* 2021년 국방합동 점검 시 ☞보훈병원이 최종 점검 후 제출한 금액

[표 3] 동일제제 영양제 일반(감면) 환자 실거래가 운영현황

병원코드	병원코드명	실거래가
MCOMLIPO1	콤비플렉스리피드페리주 1440ml	\$\$\$\$\$원 ~ \$\$\$\$\$원
M20LIPO	리피션20%주 250ml	\$\$\$\$\$원 ~ \$\$\$\$\$원
M5AA	푸라솔주 500ml	\$\$\$\$\$원 ~ \$\$\$\$\$원

4. 관계기관 의견

▲▲▲▲병원에서는 일반 ■■■병원의 환자와는 다른 장애의 특수성을 가진 국가유공자에 대한 보훈의료특수성(의료적인 요구도가 높으며, 의료자원 서비스 소모량이 많은 만성질환과 복합적인 기능 장애를 지닌 환자군)을 반영하여 보훈■■■병원 의료수가는 건강보험 요양급여비용과는 달리 운영되고 있으며, 보훈■■■병원의 운영수지를 추정·검토한 결과 단백아미노산제(3종)은 국가유공자의 예우 및 처우에 대한 특수성을 반영한 추가 보상을 위한 징수 항목이며,

「보훈병원 의료수가기준」 별표4의 별도산정기준인 ‘질병치료목적이 아닌 영양공급의 목적일 경우’에 근거하여 수가를 운영, 상기 ‘동일 목적·기준으로 같은 약제를 사용’의 의미는 감면환자의 경우에는 ■■■병원 입원 시 질병 치료를 위한 사용이며, 국비 및 고엽제 환자의 경우는 영양공급을 위한 사용으로 상이하게 운영 중이며, 타 공립■■■병원의 경우에도 단백아미노산제제(영양제)를 \$\$\$\$\$~\$\$\$\$\$\$ 사이의 금액으로 운영하고 있어 ▲▲▲▲병원의 비급여수가가 과다하지 않다고 답변하였습니다.

그러나, 동일 약제에 대해 2중 단가로 운영할 경우에는 처방목적이 명확하게 확인될 수 있게 수가를 관리·운영하여야 할 것이며, 「보훈병원 의료수가기준」 관련 비급여수가 개정 시 수가개정으로 발생될 문제점 여부를 검토하여야 하며, 수개 개정으로 인한 비급여 수가 운영에 문제점이 예상될 경우에는 즉시 본사 관련부서에 해당사항을 보고하여, 국가예산으로 지급되는 국비보상금 운영이 투명하게 이루어지도록 관리·운영하여야 할 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ☞☞보훈병원장은

- 과다 산정하여 국비보상금으로 지급받은 715건 \$\$\$\$\$, \$\$\$\$원에 대해 환급조치 하시기 바랍니다.(시정)